

02 - 02- PEC des Symptômes et des Complications en soins palliatifs - Pr. HACHIMI

(0:00 - 0:44)

Bonjour, c'est professeur Hashimi, c'est notre deuxième cours de cette série de cours des soins palliatifs, la prise en charge des symptômes et des complications en soins palliatifs. Cette série de cours comporte quatre cours, je vais traiter trois et professeur Ziedi le quatrième. Les objectifs de ce cours seront comme suit, gérer les urgences en soins palliatifs et gérer les symptômes et les complications, que ce soit neurologique, respiratoire, gastrointestinaux, cutanée ou urinaire.

(0:46 - 1:07)

Pour évaluer cette urgence, on doit répondre à six questions. La première, quel est le problème d'avoir, puis est-ce que ce problème il est réversible ou pas. Troisièmement, la correction et le traitement de cette urgence, est-ce que ça va maintenir ou améliorer la qualité de vie de ce patient.

(1:08 - 1:58)

Quatrièmement, quelle est notre évaluation clinique et en dernier, et c'est plus important, que veut le patient et que veulent les proches et la famille. On va traiter les cinq urgences les plus fréquentes qui sont l'hypercalcémie maligne, l'hémorragie massive, les crises épileptiques, la compression modulaire et le syndrome CAV supérieur. L'hypercalcémie maligne, on la trouve dans le minimum multiple, dans 10 à 20% des cancers, elle est secondaire à une lise osseuse avec libération du calcium osseux et une diminution de l'excrétion urinaire.

(1:59 - 2:55)

Ça va se manifester cliniquement par des symptômes généraux tels du douleur osseuse, une poulerie ou une poulerie d'hypsie, sur le plan digestif par de l'anorexie, nos évomissements et constipation, sur le plan neurologique avec de la somnolence, de la confusion jusqu'au coma. Pour le traitement, ça va se baser sur trois mesures, une réhydratation prudente essentiellement si le malade est en insuffisance rénale, du furosémie et des biphosphonates, par exemple le zélédrionate. L'hémorragie massive, elle est secondaire à une érosion vasculaire, à une rupture de la risse oesophagienne en cas de cirrhose, en cas de troubles de la coagulation ou une traumopénie.

(2:55 - 3:25)

Le traitement, il est local en cas d'épistaxe et il est général en commençant par arrêter les médicaments en favorisant l'hémorragie. En cas d'hémorragie digestive, le traitement est basé sur le cliotide. En cas d'insuffisance hépatique, la vitamine K, la transfusion en cas de besoin et

comme ultime mesure, c'est la sédation en cas de détresse.

(3:29 - 4:03)

Pour les convulsions, les causes les plus fréquentes sont une épilepsie préexistante, un syndrome de sevrage, un hématome ou une tumeur cérébrale, une cause métabolique ou infectieuse. Le traitement de la crise se base sur des molécules de courte durée d'action telles que le diazepam, le nidazolam ou le phenobarbital. Pour la prévention et la réduction de l'intensité des crises, c'est le valproate sodium et le phénoïne.

(4:04 - 4:41)

La compression médullaire est une urgence diagnostique et thérapeutique. Elle est secondaire à des métastases vertébrales dont la localisation dorsale est la plus fréquente dans 70% des cas, suite à un cancer du sein, du poumon, de la prostate, du rein ou une localisation de l'infarctus ou des myélomes multiples. Cliniquement, on trouve des douleurs vertébrales, une faiblesse musculaire des membres inférieurs avec des fourmillements et des picotements jusqu'aux paraplégies, des troubles sphinctériens.

(4:42 - 5:31)

Le traitement se base sur la corticothérapie et, quand c'est possible, une radiothérapie ou une chirurgie. Pour le syndrome CAV supérieur, qui est secondaire à une compression externe ou une thrombose, qui va nous donner une obstruction partielle au total de la vingt-quatre supérieures. Cliniquement, on trouve des oedèmes au niveau de la partie supérieure du corps, des troubles neurologiques avec des troubles visuels, des maux de tête et une confusion, une traduction respiratoire ou digestif à type de toux, dysphagie, dyspnée, sensation d'étouffement et une circulation collatérale.

(5:31 - 6:19)

Le traitement se base sur une corticothérapie, de la morphine, une radiothérapie d'urgence quand c'est possible et une prothèse endovasculaire quand c'est possible aussi. Après les urgences, on va voir les autres symptômes qui peuvent être d'ordre général neuropsychique, respiratoire, digestif, cutané ou urinaire. Pour les symptômes généraux, on va voir l'asthénie et l'anorexie, alors que la douleur, la déshydratation et la dénutrition seront traitées dans des cours à part.

(6:19 - 7:10)

Avec une étiopathogénie souvent multifactorielle, l'asthénie est définie comme absence ou perte de force ou d'énergie avec une faiblesse et manque de concentration. Le traitement repose sur deux volets, non médicamenteux et étiologiques. Le non médicamenteux en proposant une thérapie occupationnelle, une activité physique proportionnelle à l'état de santé du patient,

favoriser le repos nocturne et l'hygiène de sommeil, traiter inanimé par un emport de fer ou les rétropoétines, les antidépresseurs en cas de besoin et la transfusion en cas d'échec des autres thérapeutiques avec une espérance de vie acceptable.

(7:10 - 7:49)

Et ici, un tableau avec des médicaments à titre indicatif. L'anorexie est définie comme une perte d'appétit, absence de sensation de faim ou un dégoût de la nourriture. Là aussi, l'éthiopathogénie est multifactorielle, incluant des causes digestives, des douleurs non soulagées, une dépression ou une anxiété, des troubles métaboliques ou des effets secondaires des traitements.

(7:50 - 8:35)

Donc, il faut adapter l'alimentation en favorisant des goûts, des textures et des odeurs appréciées par le patient, fractionner le repas en petites quantités avec une présentation agréable, éviter les sauces et la viande, privilégier l'apport de protéines en se basant sur des produits laitiers, du poisson et du blanc d'œuf, et avec une ambiance tranquille et repos post-prandial. Et à titre indicatif aussi, on a des médicaments qu'on peut donner en cas d'anorexie. Pour les symptômes neuropsychiques, on va traiter l'anxiété et l'insomnie.

(8:37 - 9:25)

L'anxiété, qui n'est pas toujours verbalisée, c'est un sentiment pénible d'attente d'un danger imprécis avec des symptômes psychiques et physiques. Et on a deux types d'anxiété, une anxiété adaptative qui est transitoire et qui est gérable par le patient, et une anxiété pathologique qui donne une souffrance de plus en plus intense et répercute sur les relations avec l'entourage. Les idéologies peuvent être une douleur mal contrôlée, un sevrage brutal de la corticothérapie ou des psychotrapeutes, une insuffisance rénale ou respiratoire, des troubles neuropsychiques et des troubles ioniques.

(9:25 - 10:05)

En cas d'anxiété importante ou rebelle aux benzodiazepines, on doit réévaluer la situation en équipe interdisciplinaire, analyser le contexte relationnel avec la famille et l'équipe soignante et faire un appel à un intervenant tierce qui peut être un psychiatre ou l'équipe mobile de soins palliatifs. Et à titre indicatif, une liste des benzodiazepines qu'on peut utiliser en cas d'anxiété. L'insomnie est une diminution de la qualité et de la quantité du sommeil.

(10:06 - 10:47)

Elle est présente dans 40 à 60% des patients cancéreux et on a deux types d'insomnie. Une insomnie de conciliation qui est une difficulté de l'endormissement alors habituel de se coucher et une insomnie de maintien qui est une difficulté de maintenir le sommeil à cause de rêver

fréquent. Les utilisations peuvent être un mauvais contrôle des symptômes, surtout une douleur mal contrôlée, une dépression, une angoisse ou des bruits, une ambiance inadéquate ou une inactivité au cours de la journée.

(10:49 - 11:18)

Sur cette plaque, on a une liste de médicaments qu'on peut utiliser en cas d'insomnie selon la situation. Pour les symptômes respiratoires, on va traiter l'atout et la dyspnée. Pour l'atout, on doit chercher et traiter une cause, que ce soit une infection, une crise d'asthme, une poussée d'une bronchopélo-empathie chronique ou un reflux.

(11:19 - 11:55)

En cas de tout rebelle, on peut avoir recours à de la codéine, de la dextrometaphane, de la morphine ou des anticholinergiques antisécrétoires en cas de sécrétion abondante. Devant une dyspnée aiguë, il faut chercher un bronchospasme ou un encombrement et les autres signes respiratoires associés. Devant une dyspnée lentement progressive, chercher les signes de gravité, que ce soit neurologique, circulatoire ou respiratoire.

(11:56 - 12:34)

Chercher les autres signes respiratoires, le rythme, le type de respiration, les signes associés et enfin le retentissement psychologique, un type d'anxiété, répercussions sur la parole et l'activité. Sur cette plaque, vous allez trouver les différents diagnostics devant une dyspnée. Le traitement symptomatique repose sur une oxygénothérapie en cas de besoin, sur l'administration de la morphine et la corticothérapie.

(12:37 - 13:04)

En plus, l'administration des anxiolytiques et un traitement bronchodilatateur en cas de besoin. Et un traitement étiologique en fonction du diagnostic. Pour les symptômes digestifs, on va traiter le hoquet, les vomissements et la constipation.

(13:04 - 13:44)

Pour le hoquet, qui est une cause d'inconfort majeur chez les patients du fait de son intensité, les étiologies sont surtout les pathologies respiratoires et digestives. Le traitement symptomatique repose sur des antisécrétoires, des neuroleptiques, la gabapentine et la corticothérapie en cas de cause compressive. Les nausées-vomissements sont présents dans 40 à 60% des malades en soins palliatifs.

(13:45 - 14:31)

Les nausées sont une envie de vomir avec des crampes d'estomac, dégoût alimentaire et un

malaise général. Alors que les vomissements, c'est un rejet actif par la bouche du contenu gastrointestinal à différencier des régurgitations. Pour les étiologies des nausées-vomissements sont les cancers, l'éthrogénie, une hypertension intracrânienne, une cause métabolique, un encombrement bronchique avec des quintes de toux et ça pourrait être aussi psychique par peur de la maladie, angoisse de la mort et des répercussions des autres symptômes.

(14:32 - 15:34)

Devant des nausées-vomissements, il faut bien écouter et rassurer le patient et sa famille, chercher les conséquences des soins de bouche avec une hydratation selon le goût du patient en petite quantité, fractionner l'alimentation selon le goût du patient en petite quantité, changer d'aliment si on est devant une obsession vis-à-vis un aliment donné et aération de la chambre pour dégager les odeurs. Pour le traitement médicamenteux, on peut administrer de l'alopéridol plus ou moins du méthaclopramide en cas de cause iatrogène, en cas d'hypertension intracrânienne, l'alopéridol, les antisécrétoires, mais le méthaclopramide est contre-indiqué. Pour les occlusions digestives, l'alopéridol, les antisécrétoires, mais le méthaclopramide est contre-indiqué.

(15:34 - 16:15)

Pour les occlusions digestives, l'alopéridol, les antisécrétoires, mais le méthaclopramide est contre-indiqué. La constipation, qui est un symptôme fréquent, est définie par une diminution de la fréquence des défécations, rareté et dureté des selles, difficulté à déféquer, absence de selles au-delà de trois jours, défécation dure régulièrement plus que 10 minutes. Et ce symptôme, il ne faut pas le sous-estimer, il faut le prévenir avec une prescription large de laxatif obligatoire en cas de traitement par de la morphine.

(16:16 - 17:19)

Les étiologies sont essentiellement l'alimentation, l'asthémie et une diminution de la mobilité, une déshydratation, une alimentation peu abondante et pauvre en fibres et un blocage du péristaltisme intestinal, essentiellement par les oncolytiques de palier 2 et 3 et les antidépresseurs, avec un risque important de survenue de fécalons, qui est une complication. La prise en charge passe par une bonne hydratation, des aliments laxatifs riches en fibres, encourager la mobilisation du malade, aide émise aux toilettes régulièrement, massage abdominal et extraction manuelle si besoin. Et faites attention aux fausses diarrhées suite à l'obstacle ou situé.

(17:20 - 17:40)

Pour le traitement médicamenteux, on a des traitements par voie orale, des traitements par voie rectale. En première intention, les laxatifs osmotiques ou un lubrifiant. En deuxième intention, après 3 jours sans sel, associer un osmotique et un lubrifiant.

(17:41 - 18:02)

En troisième intention, si pas de sel après 48 heures après les 3 jours, un grand lavement. Pour les diarrhées, on a 4 causes fréquentes. Sur fécalons, à évoquer en premier, le traitement, c'est la prise en charge de la constipation.

(18:03 - 18:23)

En cas d'infection, il faut traiter en fonction. En cas de diarrhée, suite à des antibiotiques, arrêter les antibiotiques plus un pansement ou des levures. En cas d'ocolites radiques, le traitement repose sur une corticothérapie, un pansement intestinal ou une levure.

(18:25 - 19:12)

Pour les symptômes cutanés, on va traiter le prurite et les escarres. Les étiologies du prurite sont multiples et sont d'origine dermatologique ou systémique. Le traitement du prurite se base sur des traitements topiques locaux selon que la peau est sèche ou humide et des traitements systémiques à base d'antihistamines, des corticoïdes, des neuroleptiques, de l'hydroxyzine ou de la rifampicine en cas de cholestase hépatique.

(19:14 - 19:35)

Les escarres sont une complication fréquente en soins palliatifs. C'est une plaie de deux dents, un dehors au niveau des ondes d'appui à base chronique d'origine multifactorielle et une partie n'est pas toujours visible. Plusieurs facteurs de risque interviennent.

(19:36 - 20:04)

Des facteurs de risque extrinsèques du patient et des facteurs de risque intrinsèques qui sont en rapport avec l'état du patient et sa maladie. Plusieurs échelles sont élaborées pour évaluer le risque de survenue d'escarres. Le plus utilisé est l'échelle de Braden.

(20:05 - 20:25)

Le deuxième est l'échelle de Waterloo, mais il est un peu compliqué. Le troisième est l'échelle de Norton, mais il ne comprend pas le côté nutritionnel. Cliniquement, les escarres évoluent en quatre stades.

(20:26 - 20:43)

Le premier stade, on a une rougeur qui intéresse l'épiderme et le dernier. Le stade 2, on a une infraction de l'épiderme et du dernier. Stade 3, cette lésion arrive jusqu'au tissu sous-cutané.

(20:44 - 21:52)

Le quatrième stade, la lésion peut atteindre le muscle et l'os. Pour éviter les complications des escarres, la prévention reste prioritaire et qui passe par identifier et corriger les facteurs de risque, diminuer la pression sur les zones d'autopie avec des changements de position et de posture, surveiller l'état cutané et assurer une bonne hygiène, assurer un équilibre nutritionnel et favoriser la participation du patient et de son entourage. Pour le traitement, il y a des mesures générales qui s'articulent autour d'une anticipation de la douleur, traitement local et général, un nettoyage de la plaie uniquement avec du sérum physiologique et le traitement spécifique, il diffère en fonction de l'état de la plaie.

(21:53 - 22:25)

Sur ce tableau, vous trouverez les différents pansements en fonction du stade et de l'état de la plaie. Pour les symptômes urinaires, on va voir l'hématurie, l'incontinence urinaire, la rétention d'urine et les spasmes vésicaux. Pour l'hématurie, les étiologies les plus fréquentes sont l'infection, les tumeurs des voies urinaires et les troubles de la coagulation.

(22:26 - 23:18)

Les moyens thérapeutiques sont basés sur l'arrêt des traitements anticoagulants, faire boire le plus possible pour éviter le caillotement dans la viscille, un traitement hémostatique, des cendres urinaires à double courant pour le lavage avec du sérum physiologique et, exceptionnellement, on peut avoir recours à l'électrocoagulation ou à l'embolisation. Pour l'incontinence urinaire, les étiologies peuvent être infectieuses, tumorales ou neurologiques. Les moyens thérapeutiques passent premièrement par une bonne explication claire des symptômes aux patients et à la famille et les possibilités thérapeutiques disponibles.

(23:19 - 24:03)

Pour les médicaments, en fonction de l'étiologie, une antibiothérapie devant une infection, les immunopraminiques en cas de WC instables, la desmopressine en cas de fistules urinaires. Pour drainer les urines, on peut avoir recours aux couches, aux études péniennes ou à un sondage qui peut être intermittent ou permanent. Devant les rétentions urinaires, les principales étiologies sont l'envahissement tumoral pelvien, une obstruction érythrale, des métastases lombosacrées avec une compression médulaire, d'origine médicamenteuse ou amphicalam.

(24:03 - 24:50)

Les moyens thérapeutiques reposent sur la suppression des thérapeutiques rétentionnelles, l'élimination d'amphicalam, l'évacuation des urines en urgence et une antibiothérapie en cas d'infection. Les spasmes physiques peuvent être secondaires à un corps étranger, une infection, une tumeur, une atteinte neurologique centrale ou périphérique, peuvent être post-tradict ou post-chimiothérapie. Les moyens thérapeutiques en fonction de l'étiologie, devant une infection, une antivitérapie ou un antiseptique urinaire, les antispasmodiques, les anticholinergiques, un

sondage urinaire avec un anesthésique local.

(24:52 - 24:54)

Et merci pour votre attention.